

40. PRATICA 1 LA STRUTTURA COLICA

DURATA : 03:16

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questo video, la pratica del telaio colico viene esplorata attraverso punti di appoggio cruciali come l'arteria mesenterica e l'angolo colico sinistro. I relatori sottolineano la motilità intestinale e il suo legame con i piani psichico ed emotivo, dimostrando come alcune tensioni possano riflettere squilibri interni come la ptosi o disfunzioni viscerali. Viene evidenziata l'importanza della normotensione addominale, affrontando le problematiche di ipertensione e ipotensione. Vengono inoltre affrontate le connessioni tra il colon trasverso e le certezze personali, nonché l'impatto degli eccessi alimentari sul benessere, offrendo a studenti e terapeuti chiavi per un approccio integrativo e liberatorio.

PRATICA 1: LA CORNICE COLICA

In questa pratica, esploreremo i **punti di appoggio** essenziali nella cornice colica.

Il **primo punto di appoggio** è l'**arteria mesenterica**. Poi, il **secondo punto di appoggio** si trova all'**angolo colico sinistro**, che è fisso. Il **terzo punto di appoggio** si trova in profondità. Infine, l'ultimo punto di appoggio è legato alla dinamica dell'intestino, che si muove in senso inverso.

Il movimento che osserviamo è un movimento di **motilità**. Da questo punto, possiamo iniziare a percorrere una **storia**. Sono immediatamente attratto verso lo **stomaco**, la **milza** e l'angolo colico sinistro. Questo punto di appoggio sta riequilibrando un **piano psichico** piuttosto profondo. È possibile che cerchi di avvicinarsi a un **fulcro** più avanti per ritrovare informazioni.

Questo punto è in equilibrio tra il **piano aortico** e il **piano splenico**. È un piano di integrazione, un inconscio che desidera risalire in superficie, potendo esprimersi sotto forma di **sogno** o di **incubo**. Posizionando il punto di appoggio sul lato sinistro, cerco di ottenere una certa **libertà**.

Il punto finale si trova qui. Normalmente, la **tensione epigastrica** deve essere leggermente superiore alla **tensione ipogastrica**. Si tratta sempre di una ricerca di **normotensione addominale** o di **ipotensione addominale**. Se, durante la mia palpazione, constato che la tensione ipogastrica è superiore alla tensione epigastrica, ciò indica un sistema di **ptosi**.

In questo caso, devo lavorare su un sistema di **riequilibrio viscerospaziale** o fluido. In caso di **ipertensione**, è necessario rilasciare nuovamente i fluidi. Al contrario, per l'**ipotensione**, è richiesto un rilassamento, il che implica di reintegrare il sistema viscerospaziale per ridare **dinamica** e aumentare la forza.

È importante notare che gli **eccessi alimentari** possono ancora essere migliorati. Risalendo, osservo un angolo che si forma, e ridiscendendo, mi dirigo verso la mia **zona di gioia**. Se i problemi non vengono risolti, ciò può portare alla **zona di rabbia**.

Il **colon trasverso** rappresenta le mie **certezze** nella vita. Se queste certezze non vengono risolte, si trasformano in **dubbi**. Salendo, affronto la **zona di fiducia**, dove si trovano le mie **angosce**. L'angolo qui è quello che viene chiamato il **peso del colpevole**, che è essenziale liberare.

Infine, ridiscendendo, affronto la **ricerca della mia indipendenza**, un processo attraverso il quale devo essere totalmente libero dai miei **genitori**.

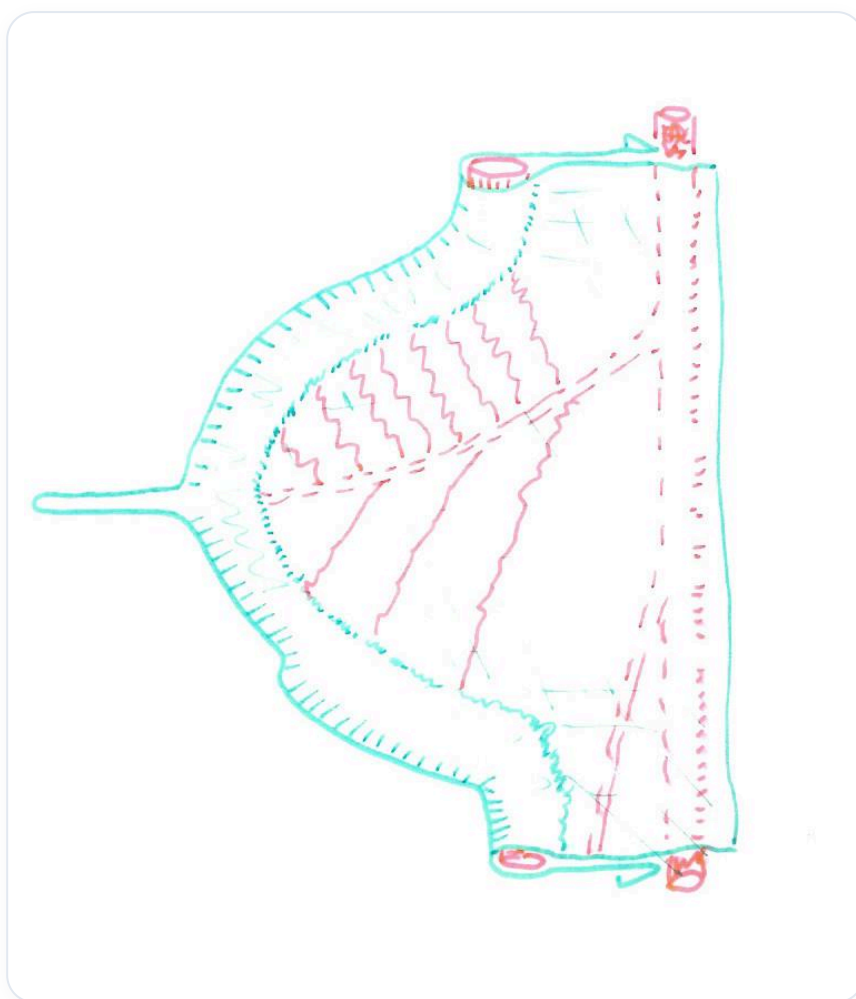


FIG. — *Tubo digerente embrionale*